



Resifriends
By Fátima Barbosa

RESIFRIENDS · BIBLIOTECA DE ESTUDO

Segurança do Paciente

Metas internacionais · Controle de infecção · Precauções —
teoria e bízus

Concurso de Enfermagem / Pernambuco · Cargo: Enfermeiro

PESO ALTO · PRIORIDADE MÁXIMA

Profa. Fátima Barbosa

PNSP (Portaria 529/2013) · Manual de Higiene das Mãos ANVISA 2026 · RDC 222/2018

O eixo que a prova adora

Segurança do paciente e controle de infecção caem em toda prova — e o enfermeiro é o protagonista desse cuidado. São pontos quase garantidos, se você dominar as metas e as precauções.

Este ebook cobre as **seis metas internacionais de segurança do paciente** (Programa Nacional de Segurança do Paciente — PNSP, Portaria 529/2013), a **higiene das mãos**, as **precauções** por tipo de transmissão e o **gerenciamento de resíduos** (RDC 222/2018). Foco no que cai e nas trocas que a banca arma.

O MAPA DESTE EIXO

- ◆ **6 metas internacionais** — o coração do tema.
- ◆ **Higiene das mãos** — os cinco momentos.
- ◆ **Precauções** — padrão, contato, gotícula e aerossol.
- ◆ **Resíduos (RDC 222/2018)** — os cinco grupos.

Sumário

1 As seis metas de segurança

Identificação

Comunicação e medicamentos

Cirurgia, mãos e quedas

2 Higiene das mãos

Os cinco momentos

Água e sabão × álcool

3 Precauções por transmissão

Padrão e contato

Gotícula × aerossol

A grande pegadinha

4 Controle de infecção e resíduos

IRAS e CCIH

RDC 222/2018

5 Síntese e bizzus finais

Quadro de revisão rápida

1

As seis metas

Instituídas pelo PNSP em 2013. Decorar as seis, na ordem, é ponto certo.

1 · As seis metas internacionais

O Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP) foi instituído pelo Ministério da Saúde por meio da **Portaria 529, de 1º de abril de 2013**. Dele derivam as seis metas internacionais, alinhadas à Organização Mundial da Saúde.

PNSP · Portaria MS nº 529/2013

META	O QUE DETERMINA
Meta 1	Identificar o paciente corretamente.
Meta 2	Melhorar a comunicação efetiva entre os profissionais.
Meta 3	Melhorar a segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos de alta vigilância.
Meta 4	Assegurar cirurgia segura (local, procedimento e paciente corretos).
Meta 5	Higienizar as mãos para prevenir infecções.
Meta 6	Reduzir o risco de danos por quedas e lesões por pressão.

◆ Meta 1 — identificação correta

A meta mais cobrada. Exige **dois identificadores** antes de qualquer cuidado (medicação, sangue, exames, procedimentos).

PEGADINHA CLÁSSICA

Os identificadores válidos são, por exemplo, **nome completo** e **data de nascimento**. O **número do quarto ou do leito NUNCA** é identificador válido — o paciente muda de leito, e o leito troca de paciente. A banca planta o número do leito como se valesse: é erro.

APROFUNDAMENTO CLÍNICO

Por que existe uma meta só para identificar o paciente — e por que ela é a primeira: porque o erro de identificação é a **raiz** de quase todos os outros. Medicação no paciente errado, sangue no receptor errado, cirurgia no paciente errado — todos começam no mesmo ponto: alguém achou que era outra pessoa.

E por que o **leito não serve** como identificador: ele é um *atributo do lugar*, não da pessoa. O paciente troca de leito, o leito troca de paciente, e a etiqueta continua ali. Já nome completo e data de nascimento **viajam com a pessoa** — mudam de setor, de hospital, de maca, e continuam sendo dela. Identificador tem que ser do paciente, não do mobiliário.

BIZU ESTRATÉGICO

Guarde a lógica das metas por blocos: **quem** (1 identificação), **como se comunica** (2), **o que administra** (3 medicamentos), **onde opera** (4 cirurgia), **como se protege** (5 mãos) e **o que previne** (6 quedas e lesão por pressão).

COMO A BANCA COBRA

“Antes de administrar medicação, o enfermeiro deve identificar o paciente utilizando, no mínimo, dois identificadores. São considerados identificadores adequados: ...”

Nome completo e data de nascimento. A alternativa com “número do leito” aparece *sempre* — às vezes combinada com um identificador válido, para confundir. Basta **um** item inválido para a alternativa cair.

2

Higiene das mãos

A medida isolada mais eficaz contra infecção. Cinco momentos que caem sempre.

2 · Os cinco momentos

A higiene das mãos é considerada a medida isolada mais importante na prevenção das infecções relacionadas à assistência. A OMS define **cinco momentos** para executá-la:

MOMENTO	QUANDO HIGIENIZAR
1º momento	Antes de tocar o paciente.
2º momento	Antes de realizar procedimento limpo ou asséptico.
3º momento	Após risco de exposição a fluidos corporais.
4º momento	Após tocar o paciente.
5º momento	Após tocar superfícies próximas ao paciente.

APROFUNDAMENTO CLÍNICO

Por que cinco momentos, e não “lave as mãos sempre”: porque “sempre” não é operacional — ninguém consegue, e a adesão despenca. Os cinco momentos existem para marcar as *transições de risco*: quando você cruza a fronteira entre o **seu mundo** e o **mundo do paciente**, e entre a **parte suja** e a **parte limpa** do próprio paciente.

Daí a diferença entre o 1º e o 2º momento, que parece redundante e não é: você lavou ao *tocar o paciente* (1), mas se vai puncionar uma veia, lava de novo (2) — porque agora está entrando num sítio estéril, e as mãos já tocaram a pele dele. O 3º momento protege *você*; o 4º e o 5º protegem o *próximo paciente*.

BIZU ESTRATÉGICO

Note a lógica: os momentos **1 e 2 protegem o paciente** (antes); os momentos **3, 4 e 5 protegem o profissional e o ambiente** (após). Guardar esse “antes × depois” ajuda a não errar a ordem.

PEGADINHA CLÁSSICA

Água e sabão **versus** álcool: quando as mãos estão **visivelmente sujas** ou com matéria orgânica, use **água e sabão**. O álcool a 70% é indicado quando as mãos *não* estão visivelmente sujas. A banca inverte isso — fique atento.

Atualização — Manual de Higiene das Mãos 2026

A **ANVISA** publicou em **2026** a nova versão do **Manual de Higiene das Mãos** — a primeira atualização em mais de **15 anos**. O documento dialoga com o **PNPCIRAS 2026-2030** (Programa Nacional de Prevenção e Controle das IRAS) e com o Plano de Ação Global para Segurança do Paciente 2021-2030 da OMS.

Pontos que a nova edição reforça:

- Os **5 momentos foram mantidos** — o infográfico clássico da OMS permanece.
- Destaque para a **Estratégia Multimodal da OMS**, com cinco componentes: **mudança de sistema** (álcool no ponto de assistência), **capacitação**, **monitoramento com retorno dos indicadores** às equipes, **lembretes** no ambiente e **cultura de segurança** com apoio da liderança.
- A higiene das mãos é ligada explicitamente ao combate à **resistência antimicrobiana (RAM)**.

Base normativa que permanece: **RDC 42/2010** (obriga a preparação alcoólica nos serviços) e **RDC 36/2013** (institui ações de segurança do paciente).

BIZU ESTRATÉGICO

A **Estratégia Multimodal** é conceito de prova: a ideia é que **treinar não basta**. Sem álcool no ponto de assistência, sem medir a adesão e devolver o dado à equipe, sem liderança engajada, o treinamento sozinho *não muda comportamento*. São **cinco componentes** agindo juntos.

3

Precauções por transmissão

Aqui mora a pegadinha mais famosa do controle de infecção: trocar gotícula por aerossol.

3 · Precauções e isolamento

As precauções **padrão** aplicam-se a *todos* os pacientes, independentemente do diagnóstico. As precauções **específicas** são adicionais, conforme o modo de transmissão.

PRECAUÇÃO	CARACTERÍSTICA E EXEMPLOS
Padrão	Para todos os pacientes. Higiene das mãos, luvas, avental, óculos/máscara conforme risco de exposição a fluidos.
Contato	Transmissão por contato direto ou indireto. Luvas e avental; quarto privativo ou coorte. Ex.: bactérias multirresistentes, Clostridioides difficile, escabiose.
Gotículas	Partículas maiores (>5 micra), curta distância (~1 m). Máscara cirúrgica. Ex.: meningite meningocócica, coqueluche, caxumba, rubéola, influenza.
Aerossóis	Partículas menores (≤5 micra), permanecem suspensas e viajam longe. Máscara N95/PFF2 e quarto com pressão negativa. Ex.: tuberculose, sarampo, varicela.

PEGADINHA CLÁSSICA

A troca mais clássica de toda a enfermagem: **tuberculose, sarampo e varicela = aerossol** (máscara N95, pressão negativa). **Meningite, coqueluche, caxumba e influenza = gotícula** (máscara cirúrgica). Trocar um pelo outro — ou dar N95 para gotícula — é o erro que a banca mais planta.

APROFUNDAMENTO CLÍNICO

Por que 5 micra é a fronteira — e por que isso muda tudo: partículas **maiores** (gotícula) são pesadas; elas caem por gravidade em cerca de 1 a 2 metros. Você se protege com *distância* e máscara cirúrgica, e o paciente pode ficar num quarto comum.

Partículas **menores** (aerossol) ficam **suspensas no ar por horas** e viajam com a corrente de ar — atravessam o quarto, saem pela porta. Contra elas, distância não protege: é preciso **filtrar** (N95/PFF2, que veda e retém partículas finas) e **controlar o ar** (pressão negativa, para que o ar do quarto não escape para o corredor).

Toda a conduta decorre do *tamanho da partícula*. Sabendo isso, você deduz a precaução sem decorar lista.

BIZU ESTRATÉGICO

Mnemônico para aerossol: **“Tô Sabendo Voar”** – Tuberculose, Sarampo, Varicela. Se voa longe e fica no ar, é aerossol e pede N95. Todo o resto respiratório comum tende a ser gotícula (máscara cirúrgica).

Detalhe cobrado: no transporte, o **paciente** usa máscara cirúrgica (mesmo em precaução por aerossol), porque ela retém as partículas na fonte; já o **profissional** usa N95 ao entrar no quarto do paciente com aerossol.

COMO A BANCA COBRA

“Paciente internado com suspeita de tuberculose pulmonar bacilífera. Além da precaução padrão, a equipe deve instituir precaução por... e o profissional deve utilizar...”

Aerossóis e máscara N95/PFF2, com quarto de pressão negativa. A pegadinha vem em duas formas: oferecer “gotículas + máscara cirúrgica” (trocando o tipo), ou acertar a precaução e errar a máscara. **Leia as duas partes da alternativa.**

4

Infecção e resíduos

IRAS, CCIH e o descarte correto. Perfurocortante é grupo E — não A.

4 · Controle de infecção e resíduos

As

IRAS (Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde) substituíram o antigo termo “infecção hospitalar”, por abrangerem também serviços ambulatoriais e domiciliares. O controle é responsabilidade da **CCIH** (Comissão de Controle de Infecção Hospitalar).

◆ Gerenciamento de resíduos (RDC 222/2018)

A ANVISA classifica os resíduos de serviços de saúde em cinco grupos:

GRUPO	O QUE É
Grupo A	Biológico (com risco de agentes infecciosos). Saco branco leitoso com símbolo de infectante.
Grupo B	Químico (medicamentos, reagentes). Risco químico.
Grupo C	Rejeitos radioativos.
Grupo D	Comum (sem risco biológico, químico ou radiológico). Equipara-se ao lixo doméstico.
Grupo E	Perfurocortantes (agulhas, lâminas, ampolas). Recipiente rígido e resistente.

APROFUNDAMENTO CLÍNICO

A lógica dos grupos é o tipo de risco, não o local onde o resíduo apareceu: **A** = risco *biológico*; **B** = risco *químico*; **C** = risco *radiológico*; **D** = *sem risco* (equipara-se ao lixo doméstico); **E** = risco *físico de perfuração*.

Por isso a agulha é **E** e não **A**, mesmo tendo sangue: o que a define é o *perigo predominante* — ela **fura**, e é furando que ela transmite. Um saco plástico com sangue não fura ninguém; a agulha, sim. A classificação segue o risco que precisa ser **contido primeiro**.

A RDC 222/2018 **revogou a RDC 306/2004** — se seu material cita a 306, está velho.

PEGADINHA CLÁSSICA

Perfurocortante é grupo **E**, e não **A**. Vai em caixa **rígida**, preenchida até o limite indicado pelo fabricante — **nunca até a borda**. Reencapar agulha é proibido. A banca adora dizer que agulha é grupo **A** ou que se enche a caixa até o topo.

5

Síntese

A página que blinda o eixo de segurança do paciente.

5 · Revisão rápida do eixo

METAS E MÃOS

- ◆ 6 metas (PNSP, Portaria 529/2013): identificação, comunicação, medicamentos, cirurgia, mãos, quedas/LPP.
- ◆ Identificação: **dois identificadores**; nunca o número do leito.
- ◆ Higiene das mãos: **5 momentos**; mãos sujas = água e sabão; limpas = álcool 70%.

PRECAUÇÕES E RESÍDUOS

- ◆ Aerossol (≤ 5 micra, N95, pressão negativa): **tuberculose, sarampo, varicela**.
- ◆ Gotícula (> 5 micra, máscara cirúrgica): **meningite, coqueluche, caxumba, influenza**.
- ◆ Contato: multirresistentes, C. difficile, escabiose.
- ◆ Perfurocortante = grupo **E**, caixa rígida. RDC **222/2018** (revogou a 306/2004).
- ◆ **Manual de Higiene das Mãos ANVISA 2026**: mantém os 5 momentos; destaca a **Estratégia Multimodal** (5 componentes). PNPCIRAS **2026-2030**.

PEGADINHA CLÁSSICA

As trocas que mais caem: (1) número do leito como identificador; (2) N95 para gotícula ou máscara cirúrgica para aerossol; (3) perfurocortante classificado como grupo A. Domine essas três e você blinda o eixo.

*“Segurança do paciente é detalhe: o identificador certo, a máscara certa, o descarte certo.
O detalhe é a questão.”*

RESIFRIENDS · BIBLIOTECA DE ESTUDO · SEGURANÇA DO PACIENTE

Conteúdo conferido em fontes oficiais: PNSP (Portaria GM/MS nº 529/2013), Manual de Higiene das Mãos da ANVISA (2026), PNPCIRAS 2026-2030, RDC 42/2010, RDC 36/2013 e RDC 222/2018. Confira eventuais atualizações de protocolos e RDCs antes da prova.